

HOSPITAL GENERAL SAN MARTÍN
SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APENDICECTOMÍA

DATOS DEL PACIENTE

Apellido y nombre: OCAMPO, Walter Daniel

DNI: 36.418.227

Edad: 34 años

HC N°: 512.093

Cama: 5-04

DIAGNÓSTICO

Apendicitis aguda con peritonitis generalizada (CIE-10 K35.0). Cuadro de 36 horas de evolución, con dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre.

PROCEDIMIENTO PROPUESTO

Apendicectomía con lavado de la cavidad abdominal, por vía laparoscópica o por cirugía abierta.

EN QUÉ CONSISTE

Bajo anestesia general se extirpa el apéndice inflamado y se lava la cavidad abdominal para retirar el pus y el material infectado. Por vía laparoscópica se realiza a través de tres pequeñas incisiones. Si durante la operación aparecen dificultades técnicas o situaciones no previstas, puede ser necesario pasar a cirugía abierta, con una incisión más amplia. Puede ser necesario dejar uno o más drenajes, que se retiran en los días siguientes. El apéndice extirpado se envía a estudio anatomopatológico. La anestesia se explica y se consiente por separado con el Servicio de Anestesiología.

BENEFICIOS ESPERADOS

Eliminar el foco de la infección, limpiar la cavidad abdominal y evitar que la infección siga avanzando.

RIESGOS FRECUENTES

Dolor en las heridas, náuseas y vómitos, fiebre en los primeros días, infección de la herida quirúrgica, acumulación de líquido bajo la herida (seroma) e íleo, es decir, que el intestino tarde algunos días en volver a funcionar. Cuando hay peritonitis, la infección de la herida y las colecciones dentro del abdomen son más frecuentes que en una apendicitis sin complicaciones.

RIESGOS POCO FRECUENTES PERO GRAVES

Absceso dentro del abdomen que requiera drenaje o una nueva operación; fístula del muñón apendicular; lesión de intestino, vejiga, uréter o vasos sanguíneos; sangrado que requiera transfusión; obstrucción intestinal por adherencias; eventración (hernia en la cicatriz); trombosis venosa y embolia pulmonar; infección generalizada (sepsis) y, en forma excepcional, muerte.

ALTERNATIVAS

El tratamiento solo con antibióticos puede considerarse en algunas apendicitis sin complicaciones, pero no es adecuado cuando hay peritonitis generalizada, porque no elimina el foco ni permite lavar la cavidad. Los antibióticos por vía endovenosa se administran antes, durante y después de la operación como complemento de la cirugía, no como reemplazo. La elección entre vía laparoscópica y cirugía abierta depende de lo que se encuentre durante la operación y del criterio del equipo quirúrgico.

RIESGOS DE NO OPERARSE

Sin cirugía, la infección sigue avanzando por el abdomen y puede pasar a la sangre (sepsis), formar abscesos, provocar obstrucción intestinal y falla de órganos. Es un cuadro que pone en riesgo la vida y que no se resuelve sin tratamiento quirúrgico.

DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Sebastián Andrés Molina me explicó, en forma clara y en un lenguaje que pude comprender, mi diagnóstico, en qué consiste la operación, sus beneficios, sus riesgos frecuentes y graves, las alternativas y las consecuencias de no operarme.

Tuve la oportunidad de hacer todas las preguntas que consideré necesarias y fueron respondidas a mi satisfacción.

Comprendo que la medicina no es una ciencia exacta y que no se me han garantizado resultados.

Autorizo al equipo quirúrgico a adaptar el procedimiento si durante la operación aparecen situaciones no previstas, y autorizo el estudio anatomopatológico del apéndice extirpado.

En forma libre y voluntaria, doy mi consentimiento para que se me realice una apendicectomía.

POSIBILIDAD DE REVOCAR

Sé que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento antes de la operación, sin necesidad de explicar mis motivos, y que esa decisión no afectará la atención que recibo en esta institución.

Lugar y fecha: Hospital General San Martín, 22/09/2026, 20:15 h

Firma del paciente: _____

Aclaración: Walter Daniel Ocampo

DNI: 36.418.227

Firma del cirujano: _____

Aclaración: Dr. Sebastián Andrés Molina

Especialista en Cirugía General, Matrícula 132.905

Firma del testigo: _____

Aclaración: Mirta Beatriz Ocampo

DNI: 34.975.106

Vínculo con el paciente: hermana

REVOCACIÓN (completar solo si el paciente decide revocar este consentimiento)

Yo, _____, DNI _____, revoco el consentimiento otorgado en este documento.

Firma: _____ **Fecha:** ____/____/____